

Examen Classant National Q12- Cancer du Cavum

QCM 1

Le cancer du cavum est :

- A. Est le 2^{ème} cancer chez l'homme
- B. A une similarité avec les cancers VADS pour certaines histologies
- C. Le type UCNT est lié au virus HPV
- D. Le taux de métastases élevé explique les échecs du traitement
- E. Peut guérir par la radiothérapie

QCM 2

Quel est le principal rapport postérieur du cavum ?

- A. Corps de l'os sphénoïde
- B. Apex du rocher
- C. Processus ptérygoïde
- D. Processus basilaire de l'os occipital
- E. Sinus caverneux

QCM 3

Les parois latérales du cavum :

- A. Sont musculo-aponévrotiques
- B. Répondent en arrière à l'espace rétropharyngien
- C. Sont limitées en profondeur par le fascia pharyngo-basilaire
- D. Répondent au-dessous de l'ostium à la trompe auditive
- E. Répondent aux espaces profonds de la face au-dessus de l'orifice tubaire

QCM 4

Quelle structure est proche du toit du cavum ?

- A. Hypophyse
- B. Nerf optique
- C. Bulbe olfactif
- D. Sinus sphénoïdal
- E. Lame criblée

QCM 5

Quels sont les rapports du cavum ?

- A. Le rapport avec l'espace rétro pharyngien se fait à travers les muscles prévertébraux
- B. La paroi supérieure a un rapport avec le sinus caverneux à travers la base du crâne
- C. La paroi postérieure a un rapport avec arc antérieur de l'axis
- D. Le processus basilaire a un rapport avec la paroi supérieure et postérieure du cavum
- E. La paroi latérale a un rapport avec la fosse cérébrale moyenne

QCM 6

Le drainage lymphatique du nasopharynx :

- A. L'atteinte du ganglion de Rouvière se voit dans 70 % des cas en présence d'adénopathie cervicale
- B. La chaîne axillaire si atteinte est considérée métastatique
- C. La confluence du spinal accessoire et de la veine jugulaire est appelée sus claviculaire
- D. Se fait via les ganglions sous maxillaires
- E. Le réseau lymphatique du toit et des parois latérales est particulièrement riche

QCM 7

Comment est le drainage lymphatique du cavum ?

- A. Il se fait par des voies communes à la cavité buccale
- B. Il est croisé
- C. L'adénopathie du secteur VI peut révéler l'UCNT
- D. Il est rétrograde
- E. Il explique l'atteinte ganglionnaire comme signe révélateur le plus fréquent

QCM 8

Quel(s) symptôme(s) peut (peuvent) révéler une extension supérieure (endocrânienne) du cancer du nasopharynx ?

- A. Une obstruction nasale unilatérale
- B. Une ophtalmoplégie en cas d'envahissement du sinus caverneux
- C. Un syndrome de l'apex orbitaire
- D. Une hypoacousie
- E. Un envahissement des muscles pré-vertébraux

QCM 9

Quels signes peuvent indiquer une extension latérale du cancer du nasopharynx ?

- A. Une hypoacousie ou une otalgie
- B. Une obstruction nasale unilatérale
- C. Une exophtalmie
- D. Une atteinte neurologique par extension vers les espaces profonds
- E. Un syndrome de l'apex du rocher

QCM 10

La propagation de la tumeur du cavum se fait :

- A. Vers l'espace rétrostylien à travers l'espace rétropharyngien
- B. vers l'oreille moyenne à travers la trompe auditive
- C. Vers la fosse infra temporale à travers la fosse ptérygomaxillaire
- D. Vers l'orbite à travers la fissure orbitaire supérieure
- E. Vers le sinus caverneux à travers le foramen ovale

QCM 11

Comment expliquer l'atteinte au cours du cancer du cavum ?

- A. L'ophtalmoplégie par l'atteinte de l'apex orbitaire ou sinus caverneux
- B. L'atteinte des nerfs mixtes par extension à l'espace rétrostylien et au foramen carotidien
- C. L'atteinte du V3 par extension à l'espace parapharyngien ou foramen ovale
- D. Le trismus par atteinte de l'espace masticateur au niveau de la FIT
- E. L'atteinte du V dans ses 3 branches se voit par atteinte de l'apex pétreux

QCM 12

Le carcinome du nasopharynx est de fréquence variable :

- A. Intermédiaire pour l'Europe qui fait partie du pourtour méditerranéen
- B. Intermédiaire pour le pourtour méditerranéen (Tunisie et moyen orient)
- C. D'incidence élevée en Asie du Sud Est
- D. Selon le groupe sanguin du malade
- E. La fréquence varie selon l'âge des patients

QCM 13

L'âge moyen de survenu du carcinome du nasopharynx :

- A. Dans les pays à haut risque : 1 seul pic
- B. En Tunisie : 3 pics de fréquence
- C. Dans les pays à faible risque, le pic est souvent supérieur à 70 ans
- D. En Tunisie, avant 18 ans, c'est la tumeur épithéliale la plus fréquente
- E. Dans les pays à risque intermédiaire, le premier pic est entre 10 et 24 ans

QCM 14

Quelle(s) est (sont) la (les) caractéristique(s) du CNP ?

- A. Le carcinome épidermoïde est prédominant quel que soit la région
- B. La forme kératinisante est la plus fréquente dans les zones de forte incidence
- C. La forme kératinisante est liée à la consommation de tabac et alcool
- D. Dans les zones de faible intensité, la forme kératinisante peut atteindre 70%
- E. La forme kératinisante est liée à la consommation de Neffa

QCM 15

Concernant la histopathologie du carcinome du nasopharynx :

- A. Le carcinome non kératinisant est identique à celui de la cavité buccale
- B. Le carcinome kératinisant est moins sensible à la radiothérapie que l'indifférencié
- C. L'UCNT est lié à des facteurs génétiques
- D. L'UCNT comporte des marqueurs antigénique EBV
- E. Le type basaloïdes est le deuxième de point de vue fréquence

QCM 16

L'aspect histologique de l'UCNT :

- A. Est formé de petites cellules
- B. Est formé de cellules à limites floues
- C. Est formé de cellules pourvues de noyaux foncés
- D. Est formé de cellules entouré d'un stroma lymphocytaire abondant
- E. A une cellularité disposée en amas

QCM 17

Les facteurs de risque de d'UCNT :

- A. Nitrosamines volatiles surtout consommé à l'enfance
- B. Surconsommation de salaisons
- C. Alcool
- D. Virus de la famille des herpes
- E. Tabac

QCM 18

Les anticorps sériques élevés au cours du CNP sont :

- A. IgA anti-EA
- B. IgG anti-EBV
- C. IgA anti-VCA
- D. IgM anti-EBV
- E. IgG anti-EA

QCM 19

Quels signes sont de mécanisme neuro-ophtalmiques dans le cadre d'un CNP ?

- A. Diplopie par atteinte du VI
- B. Névralgie faciale supérieure
- C. Exophtalmie
- D. Trismus isolé
- E. Refoulement de l'amygdale

QCM 20

Les signes d'appel pour le CNP :

- A. La voix nasonnée est secondaire à une obstruction de la trompe d'Eustache
- B. L'ADP trainante infra-cricoïde est fréquente
- C. Les signes otologiques peuvent persister en post thérapeutique
- D. L'ADP peut être douloureuse
- E. L'atteinte du VI peut être due à une atteinte de l'apex orbitaire, sinus caverneux ou apex pétreux

QCM 21

L'atteinte ganglionnaire au cours du CNP :

- A. Est expliquée par l'infection EBV
- B. Est en premier au niveau sous digastrique
- C. Peut être prévalente à la tumeur de plusieurs mois
- D. Est de bon pronostic vu sa réponse rapide à la chimiothérapie
- E. Est plus fréquente dans le carcinome bien différencié

QCM 22

L'atteinte du VI au cours du CNP peut être expliquée par :

- A. L'extension à l'apex du rocher
- B. L'extension à la paroi latérale du sinus caverneux
- C. L'extension à l'apex orbitaire
- D. L'extension au foramen jugulaire
- E. L'extension au foramen condylien

QCM 23

Parmi ces signes cliniques, quels sont les signes révélateurs dans plus de 40 % des cas de CNP ?

- A. Dysphonie
- B. Dysphagie
- C. Adénopathie cervicale
- D. Autophonie
- E. Épistaxis

QCM 24

Quelle est la triade clinique typique du syndrome du cavum ?

- A. Obstruction nasale, otite séreuse, paralysie faciale
- B. Rhinorrhée postérieure, acouphène, tuméfaction cervicale
- C. Obstruction nasale, hypoacousie, adénopathie cervicale
- D. Otalgie, dysphonie, dyspnée
- E. Rhinorrhée, fièvre, tuméfaction cervicale

QCM 25

Une adénopathie cervicale persistante unilatérale sans autre signe ORL doit faire évoquer :

- A. Une tuberculose ganglionnaire
- B. Un lymphome
- C. Une tumeur du cavum
- D. Une angine streptococcique
- E. Un cancer de la langue

QCM 26

Un syndrome de l'apex du rocher survenant au cours d'un cancer du cavum se caractérise par :

- A. L'atteinte unilatérale de tous les nerfs crâniens
- B. L'atteinte du III, IV, VI et V1
- C. L'atteinte de la V^{ème} et VI^{ème} paire crânienne
- D. L'extension vers la paroi latérale du sinus caverneux
- E. L'extension endocrânienne

QCM 27

Le trismus observé chez un patient présentant un cancer du cavum peut être dû à :

- A. Extension au foramen rond
- B. Une atteinte du V moteur
- C. Extension à la fosse infratemporale
- D. Une atteinte des muscles prévertébraux
- E. Une atteinte des muscles ptérygoïdiens

QCM 28

En cas de suspicion de CNP :

- A. L'examen à lui seul permet de suspecter les formes de mauvais pronostic
- B. La rhinoscopie antérieure avec rétraction permet d'examiner le nasopharynx
- C. L'examen par nasofibroscope permet d'évaluer l'extension à la cavité nasale
- D. L'examen otoscopique est systématique
- E. L'acoumétrie permet de chercher une surdité de perception fréquente dans ce cadre

QCM 29

L'examen de la cavité buccale au cours du CNP :

- A. Permet d'évaluer l'atteinte de 4 nerfs crâniens
- B. Permet d'évaluer les ADP rétro-pharyngiennes
- C. Évalue l'extension au reste du pharynx
- D. Peut être utilisé à la biopsie
- E. Guide les soins dentaires en pré-chimiothérapie

QCM 30

L'examen neurologique au cours du CNP:

- A. Peut à lui seul classer la tumeur en T4
- B. Peut évoquer les extensions de la tumeur
- C. L'atteinte des oculomoteurs est en faveur d'une extension postéro latérale
- D. L'atteinte des nerfs mixtes est signe d'extension postéro latérale
- E. Montre souvent des signes méningés

QCM 31

Les symptômes suivants altèrent le pronostic de malade atteint d'UCNT :

- A. Hippocratisme digital
- B. Présence d'ADPs cervicaux groupe IV
- C. Hypoacousie
- D. Diplopie
- E. Trouble hématologique

QCM 32

Le cancer du nasopharynx de l'enfant :

- A. Est moins radiosensible
- B. Est associé à volume tumoral local important
- C. Est associé à un taux élevé de syndrome paranéoplasique
- D. L'UCNT est le plus fréquent
- E. Le type rhabdomyosarcome est la deuxième localisation après l'orbite

QCM 33

Le bilan pré-thérapeutique d'un CNP doit comporter :

- A. Un bilan thyroïdien
- B. Une consultation d'onco-fertilité si une chimiothérapie est prévue
- C. Une CRP pour chercher un syndrome inflammatoire
- D. Le dosage LDH si suspicion de métastases pulmonaires
- E. Un bilan cardiaque systématique

QCM 34

Le dosage des anticorps EBV en cas de cancer du cavum a un rôle dans :

- A. Le diagnostic histologique de la maladie
- B. L'orientation du diagnostic devant une adénopathie cervicale en apparence primitive
- C. Le choix thérapeutique
- D. La surveillance après traitement
- E. Le dépistage chez les patients les plus exposés en zones à haut risque

QCM 35

La radiothérapie au cours des carcinomes du nasopharynx :

- A. Inclut dans le volume cible les ganglions cervicaux non atteints
- B. Vise l'espace rétro-pharyngien systématiquement
- C. Se fait idéalement par technique conformationnelle
- D. La thyroïde est systématiquement protégée
- E. L'hyperfractionnement est le meilleur protocole

CAS CLINIQUE 1

Amine, âgé de 22 ans, sans antécédents, consulte en ophtalmo pour diplopie récente avec céphalées depuis 2 mois.

Examen :

- Difficulté de porter l'œil gauche en dehors
- Hypoesthésie de l'hémiface gauche
- Endoscopie nasale: tumeur du toit du cavum et à la paroi latérale gauche
- Cou: Adénopathie secteur II bilatéral 3 cm , secteur IV gauche 2 cm

Le diagnostic probable est un UCNT

QCM 36

L'atteinte neurologique que présenterait ce patient serait en rapport avec :

- A. Extension à la fosse infratemporale
- B. Extension à l'espace rétrostylien
- C. Atteinte de l'apex du rocher
- D. Atteinte du sinus caverneux
- E. Atteinte la fissure orbitaire supérieure

Le bilan réalisé chez ce patient montre

- Sérologie EBV : Ig A anti EA positive
- Cytoponction ganglionnaire: présence de cellules tumorales
- Biopsie du cavum: UCNT
- IRM du cavum: tumeur du nasopharynx, extension à l'oropharynx et endocrânienne, Adénopathie rétropharyngienne de 2cm à gauche
- TDM thoraco abdominale sans anomalie
- Scintigraphie osseuse: hyperfixation au niveau de la base du crâne

QCM 37

Le diagnostic d'UCNT était possible par :

- A. l'IRM ayant montré la tumeur
- B. La sérologie EBV positive
- C. La biopsie du cavum
- D. La cytoponction ganglionnaire
- E. La scintigraphie osseuse

QCM 38

Concernant les explorations de ce patient :

- A. Les constatations de la scintigraphie font classer la tumeur en métastatique
- B. La sérologie EBV a un impact sur la décision thérapeutique
- C. La sérologie EBV a une valeur à la surveillance post thérapeutique
- D. La découverte d'adénopathie rétro-pharyngienne change la classification clinique
- E. La cytoponction permet de guider les secteurs ganglionnaires à irradier

QCM 39

Classez la tumeur chez ce patient :

- A. T4N1M0
- B. T3N3M0
- C. T4N3M0
- D. T4N2M0
- E. T3N2M0

QCM 40

Quels sont les facteurs de mauvais pronostic chez ce malade :

- A. L'extension endocrânienne
- B. La cytoponction ganglionnaire positive
- C. La localisation ganglionnaire rétro-pharyngienne
- D. Le sexe masculin
- E. La sérologie EBV positive

QCM 41

Le traitement à proposer à ce patient :

- A. Chimio-radiothérapie concomitante
- B. Chimiothérapie néoadjuvante suivie de chimio radiothérapie concomitante
- C. Radiothérapie avec curiethérapie
- D. Radiothérapie tumorale + curage ganglionnaire
- E. Chimiothérapie palliative

QCM 42

Quels sont les explorations à faire en pré-thérapeutique chez ce patient :

- A. LDH
- B. Panendoscopie
- C. Audiogramme
- D. Bilan thyroïdien
- E. NFS

QCM 43

Parmi les examens suivants, lesquels sont utilisés dans le suivi du patient après la fin de son traitement ?

- A. IRM annuelle
- B. Sérologie EBV à 3 mois puis tous les 6 mois
- C. TEP-TDM si suspicion de récurrence
- D. NFS-plaquettes mensuelle
- E. Audiogramme tous les ans

	1 ^{ère} année	2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	4 ^{ème} année	5 ^{ème} année	Au-delà
Clinique	/3 mois	/3 mois	/6 mois	/6mois	/6 mois	/ an
Dentaire si dents+	/6 mois	/6 mois	/6 mois	/6 mois	/6 mois	/6 mois
IRM ou TDM cavum	À 3 mois après la fin du ttt	/an ou si signes d'appels	/an ou si signes d'appels	/an ou si signes d'appels	/an ou si signes d'appels	/an ou si signes d'appels
Bilan d'extension : TDM thoracique, écho abdominale, scinti osseuse	/an	/an	/an	Signes d'appels	Signes d'appels	Signes d'appels
Bilan thyroïdien	/an	/an	/an	/an	/an	/an
Sérologie EBV	À 3 mois de la fin du ttt	/6mois si Ac + pré ttt	/6mois si Ac + pré ttt	/6mois si Ac + pré ttt	/6mois si Ac + pré ttt	/6mois si Ac + pré ttt